

Objawy *negatywne*

Nie krzyczą jak halucynacje, ale niszczą życie równie skutecznie. To deficyty motywacji, przyjemności i ekspresji — nie lenistwo i nie depresja.

CZAS: 12 min Po stabilizacji objawów pozytywnych

ŹRÓDŁO: Marder & Galderisi (2017); Fusar-Poli i in. (2015); Gard i in. (2007); Firth (2015)

JAK UŻYWAĆ

Rozpoznaj **pięć domen** objawów negatywnych (sekcja 1), odróżnij **pierwotne** od **wtórnych** (sekcja 2). W sekcji 5 zaplanuj jeden mały krok na ten tydzień.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fusar-Poli i in. (2015, meta-analiza): objawy negatywne są **najsilniejszym predyktorem funkcjonowania społecznego i zawodowego** po epizodzie psychotycznym. Antypsychotyki *słabo* na nie działają — leczenie wymaga interwencji nefarmakologicznych. To nie „lenistwo” — to neurobiologiczny deficyt przetwarzania nagrody (Strauss i in., 2014).

01 Pięć domen objawów negatywnych

Skala BNSS (ang. *Brief Negative Symptom Scale*, Kirkpatrick 2011) wyróżnia pięć domen. Każda jest **osobna** — można mieć silną anhedonię i jednocześnie zachowaną mowę.

ANHEDONIA

brak przyjemności

Spadek zdolności do odczuwania przyjemności z aktywności, które wcześniej cieszyły. Zwłaszcza *antycypacyjna* (patrz sekcja 4).

AWOLICJA / APATIA

brak motywacji do działania

„Chcę, ale nie mogę zacząć”. Trudność z inicjowaniem działania nawet wtedy, gdy wiesz, że jest potrzebne.

ASOCJALNOŚĆ

wycofanie społeczne

Spadek zainteresowania kontaktem. To *nie* lęk społeczny — tu interakcja przestaje być nagradzająca.

ALOGIA

zubożenie mowy

Krótsze, rzadsze, mniej spontaniczne wypowiedzi. Czasem trudno znaleźć słowa, nawet gdy myśli są obecne.

SPŁYCZONY AFEKT

zredukowana ekspresja emocji

Mniej mimiki, gestów, modulacji głosu. **Ważne:** nie znaczy „brak emocji wewnątrz” — emocje są obecne, ale nie wychodzą na zewnątrz.

02 Pierwotne czy wtórne — kluczowe rozróżnienie

Carpenter i in. (1988): ok. **60% objawów negatywnych jest wtórnych** — wynika z czegoś, co da się zmienić. Tylko 40% to *pierwotne* (deficytowe). **Każde podejście kliniczne zaczyna się od tej różnicy.**

WTÓRNE · ~60%

Spowodowane: *sedacją od antypsychotyków, depresją, izolacją społeczną, demoralizacją*. Każda z tych przyczyn ma osobne podejście — redukcja leku, antydepresant, IPS, CBTp.

PIERWOTNE · ~40%

Bezpośrednio z choroby. Najtrudniejsze do leczenia. Wymagają rehabilitacji poznawczej, aktywizacji behawioralnej i cierpliwości — czasem próby kłozapiny.

03 Co realnie pomaga

AKTYWIZACJA BEHAWIORALNA

Mikrokroki, nie wielkie cele. „Dziś 10 min spaceru”, nie „znajdę pracę”. Budowanie od najmniejszej możliwej czynności w górę. Działanie *poprzedza* motywację.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Firth i in. (2015, meta-analiza): ćwiczenia aerobowe 3×/tydz. po 30 min redukują objawy negatywne. Lepsze niż większość interwencji farmakologicznych dla tego wymiaru.

WSPOMAGANE ZATRUDNIENIE

Model IPS (ang. *Individual Placement and Support*): praca jako **narzędzie zdrowienia**, nie efekt uboczny zdrowienia. Struktura dnia, sens, kontakt — naturalne lekarstwo na wycofanie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

SST (ang. *Social Skills Training*, Bellack 2004): strukturyzowany trening rozmowy, asertywności, rozwiązywania problemów. Krok po kroku, w bezpiecznej grupie lub z terapeutą.

04 Ważne odkrycie — antycypacja vs konsumpcja

Gard i in. (2007): w psychozie zdolność do **doświadczania** przyjemności w *trakcie* aktywności (przyjemność konsumpcyjna) jest często *zachowana*. To, co jest uszkodzone, to **zdolność do przewidywania** przyjemności (antycypacyjna). Pacjent *nie wie*, że spacer go ucieszy — więc nie idzie.

Praktyczna implikacja: nie pytaj „czy chcesz iść na spacer?” — odpowiedź będzie „nie” (brak antycypacji). Powiedz: „chodźmy na spacer” — w trakcie pacjent zazwyczaj **poczucie** przyjemność, choć nie przewidział. To zmienia rolę rodziny i terapeuty: zachęta zewnętrzna, nie czekanie na motywację.

05 Mój mikrokrok na ten tydzień

JEDNA KONKRETNA MAŁA CZYNNOŚĆ

— wykonalna w 15 minut, dziś lub jutro

KTO MOŻE MI POMÓC ZACZAĆ

— bliska osoba, terapeuta, peer-support

-------------	-------------

Klucz: Marder & Galderisi (2017): objawy negatywne to *cichy złodziej życia*. Nie krzyczą jak głosy, ale stopniowo redukują pracę, naukę, relacje. Najtrudniejsze do leczenia, najbardziej predyktywne dla funkcjonowania — i jednocześnie **najbardziej zaniedbane** w leczeniu rutynowym, gdzie skupia się głównie na redukcji halucynacji i urojeń. *Aktywizacja, ruch, wspomagane zatrudnienie i nie czekanie na motywację* — to są fundamenty pracy z tym wymiarem psychozy.